

平潭综合实验区社会事业局 文件 平潭综合实验区财政金融局

岚社会医保〔2022〕38号

平潭综合实验区社会事业局 平潭综合实验区财政金融局 关于印发《紧密型县域医疗卫生共同体医保基金打包支付方案（试行）》的通知

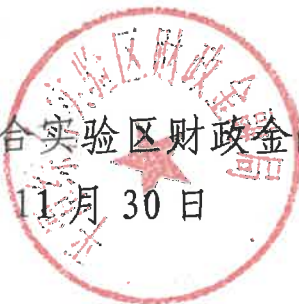
区行政服务中心、区总医院：

现将《紧密型县域医疗卫生共同体医保基金打包支付方案（试行）》印发给你们，请认真贯彻执行。

平潭综合实验区社会事业局



平潭综合实验区财政金融局
2022年11月30日



平潭综合实验区社会事业局
平潭综合实验区财政金融局
关于紧密型县域医疗卫生共同体医保基金
打包支付方案（试行）

根据《福建省紧密型县域医疗卫生共同体医保基金打包支付指导意见》（闽医保〔2022〕114号）精神，为推动我区紧密型县域医疗卫生共同体建设，加速建立医保基金打包支付制度，进一步深化我区医保支付方式改革，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把人民健康放在优先发展的战略地位，以组建紧密型县域医疗卫生共同体（以下简称：医共体）为载体，以实施医保支付方式改革为切入点，按照“总额包干、结余留用、合理超支分担”的原则，在确保医疗水平不降低、服务质量有保障、就医负担不增加的前提下，以当年基本医疗保险基金收入预算为基础，实行医共体医保基金打包制度，以医保打包支付为主要纽带，促进医共体各成员单位形成利益共同体，推动医共体从治已病为中心转向治已病与治未病并重，最终向以人民健康为中心转变，促进健康福建战略实施，使人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

二、实施范围和内容

医共体医保基金打包支付的实施范围包括医共体县域内所有参保人员（含异地安置参保人员），医共体涵盖范围按照我区医共体建设相关方案执行。

（一）全面实施医保基金总额预算管理

1. 分类预算基金收入。区行政服务中心（医保经办机构）应根据上一年度职工医保（含生育保险，下同）和居民医保的基金征缴收入、参保人员变动、基金征收标准调整、征缴基数变动、征缴费率调整等因素，分别编制预算年度的职工医保、居民医保的基金收入预算。

2. 分类预算基金支出。按照以收定支原则，综合考虑近年医保基金结余情况、医保待遇政策调整等因素，分别编制预算年度的职工医保、居民医保的基金支出预算。

（1）职工医保：根据前三年统筹基金结余情况（按 1: 3: 6 加权平均）预留结余额度，或按预算年度统筹基金预算收入不低于 3% 的比例提取风险调节金，两者相比按就高原则确定基金留存数。基金预算收入减去基金留存数，即为预算年度基金支出预算数。

（2）居民医保：按预算年度统筹基金预算收入 3% 的比例提取风险调节金，基金预算收入减去风险调节金，即为预算年度基金支出预算数。

（二）明确医共体基金打包范围

要围绕建立医共体的初衷和目标，按照权责相当、利责相适的原则，合理确定医共体医保基金打包范围。其中，家庭医生签约由基金负担部分应单列预算，由医保经办机构统一核算，并会同卫健部门考核后支付。

（三）医共体打包医保基金的核定

应就职工医保、居民医保分别预算医共体医保打包基金。

1. 确定可分配基金总量。预算年度基金支出预算数减去以下项目预算数后，即为可分配基金总量：

- （1）划入个人账户基金预算；
- （2）生育津贴支出预算；
- （3）其他不应或暂不具备条件打包的统筹基金支出。

以上 3 项由医保经办机构统一支付和核算。

2. 打包基金修正。将稽核的违规违约扣款金额作为医共体打包基金的调整项，扣减医共体打包基金预算。按倍处理的违约金部分不作为扣减项，不扣减医共体打包基金预算。

（四）衔接区域点数法总额预算

参与开展 DIP 试点的医共体，从医共体打包医保基金预算中，按该医共体纳入区域点数法与按病种分值付费（DIP）项目的预算金额，划入 DIP 总额预算。第二年度起，按其上一年度从 DIP 总额预算中所得数额和 DIP 总额预算增长率计算划入 DIP 总额预算，并按 DIP 试点办法参与分配和计算应得数额。

（五）明确医共体打包基金支出范围

医共体基金打包的基金支出范围与基金打包的口径应完全一致，包括医共体所有参保人员在医共体内和医共体外医疗机构就医基本医保待遇支出、大病保险和大额医疗费用保险待遇支出等。我区统一招标采购城乡居民大病保险、职工大额医疗费用保险的，从医共体打包医保基金预算中扣抵，保费盈余按照相关协议规定执行。

医共体外其他医疗机构就医发生的医保统筹基金支出，由医保经办机构与医共体签订协议，委托医保经办机构直接结算，结

算金额从医共体打包基金总额中支出。医共体对医保经办机构直接结算的医疗费用有异议的，医保经办机构应与医共体一起核验，按规定维护各方利益。

（六）实行打包基金按月预拨、年终结算

医保经办机构应按打包基金减去医共体外其他医疗机构就医基本待遇支出后的90%按月预拨，并根据绩效考核方案，年终统一结算，多还少补。应预拨不少于一个月的周转金，用于减轻医共体垫资负担。

（七）建立完善医共体基金打包考核机制

我区结合实际制定绩效考核的具体实施方法，围绕提升基金使用效率的目标，合理设置考核指标，并将考核结果与医共体医保打包基金结算挂钩，强化考核结果运用。

（八）严格落实“总额包干、结余留用、合理超支分担”

1. 明确合理超支分担责任的界限。对当年医保打包基金超支部分，由医保部门、医共体双方共同分析，理清职责，协商确定合理超支的金额和分担比例。因医保待遇政策、医疗服务价格调整等导致基金合理超支的部分，根据医保基金结余情况，从预留的风险基金中支付给医共体，非合理原因超支医保基金不予支付。超出医共体打包金额100%以上110%以下部分，超支部分由医保基金按50%的标准分担；110%以上120%以下的部分，医保基金按25%的标准分担；超过120%以上部分，医保基金分担比例为0%。减少基金支出的结余部分，留归医共体。因执行国家、省集中带量采购药品耗材导致基金支出增减的，不再单独预算和结余留用。因重大疫情等紧急情况发生的医疗救治费用，按相关政策

执行。

2. 年终结算后医保打包基金结余部分(含参与 DIP 改革所得收入等)为医共体结余留用资金。落实“两个允许”，医共体结余留用资金按规定提取各项基金后主要用于医共体内人员薪酬或奖励。

(九) 持续加强对医共体的监督和建设

1. 加强医共体协议管理和监督监测。医保部门要将医保基金日常监管和专项治理工作相结合，监督重心要从事后稽核转为事前提醒和事中拦截，促进医保基金合理使用。重点监督推诿病人、服务质量下降以及转移医疗费用损害参保人利益等行为，既要防止过度治疗，又要防止治疗不足，既要防止无序转外就医，又要防止过度留治，动态监测医共体医疗费用、转外就医、基金运行等情况，及时向医共体反馈信息及加强业务指导。

2. 完善医共体内部绩效分配制度。卫健部门要督促医共体完善内部绩效考核和薪酬分配机制，使外部基金打包转化为医共体内部利益趋同，促进医共体内部完善内控约束、绩效管理制度，形成相互监督、和谐共存的“利益共同体”。

四、保障措施

(一) 加强部门联动

要坚持党的领导，发挥好党领导一切的统领作用。区医保、卫健、财政等部门要加强合作，形成合力，增强医保、医疗、医药联动改革的整体性、系统性、协同性。要积极创新机制，主动发挥职能作用，推进上下联动，构建一体化管理模式，完善政策措施，推动县域医共体建设稳步发展。

（二）加强政策保障

1. 建立医保打包谈判协商机制。医保经办机构与医共体代表共同参与医保打包各环节工作的决策，建立谈判协商机制，促进实现利益同向化，推动医保打包支付改革良性发展。

2. 落实国家及我区药械集中采购政策。原则上由医共体内统一组织药品耗材采购、配送、结算等，满足医共体内基层医疗机构常见病及诊断明确稳定的慢性病患者用药需求。

3. 完善转外就医审核流程。探索建立由医共体参与的参保患者县域外就诊审核和病情研判机制，提高医保资金使用效率。参保患者不按规定转外就诊产生的费用，降低医保报销比例。

4. 提高县域医保服务能力。一是着力提高城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助经办服务水平，实现“一站式服务、一个窗口办理、一单制结算”。二是全面落实低收入人口“先诊疗后付费”“一站式”结算和异地就医直接结算。三是继续强化医保服务站功能，拓展便民利民举措，不断创新服务方式，为区域内参保群众提供安全便捷服务，保证医保经办工作平稳有序开展。

（三）加强宣传引导

社会事业局将指导区总医院不断加强医共体医保政策宣传引导和医保业务培训，确保医共体区域内参保人知晓医保政策、医务人员熟知各项医保业务流程。积极营造改革氛围，充分调动各方特别是基层医护人员、村医参与医共体改革的积极性、主动性和创造性，形成工作合力，确保改革顺利推进。

本方案从2023年1月1日起执行。

